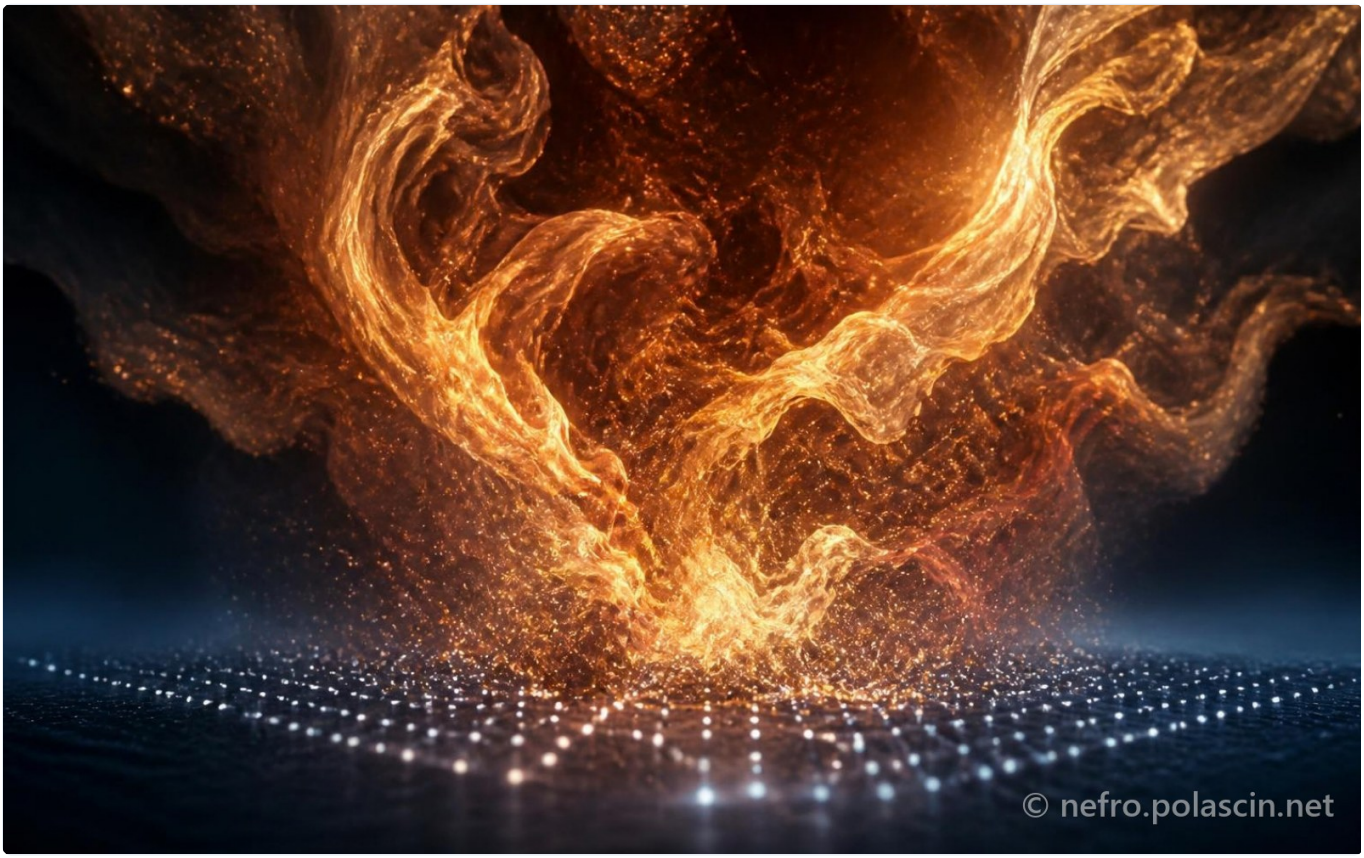
Kvalitatívny výskum v nefrológii: čo čísla neukážu o rozhodovaní pri CKD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.07.2026



Ilustračná scéna. To, prečo sa pacient rozhodne tak či onak, sa do mriežky premenných nezmestí – a pritom práve to rozhoduje.

Randomizovaná štúdia môže ukázať, či intervencia znižuje riziko klinickej udalosti. Register odhalí, ako často sa udalosť vyskytuje a s čím súvisí. Ani jeden prístup však sám osebe nemusí vysvetliť, ako pacient chápe svoje ochorenie, prečo odmieta navrhovanú liečbu alebo čo mu bráni uskutočniť plán, s ktorým v ambulancii súhlasil.

Práve na takéto otázky je určený kvalitatívny výskum. Skúma významy, skúsenosti, vzťahy a kontext, v ktorom ľudia konajú a rozhodujú sa. V nefrológii môže objasniť liečebnú záťaž, voľbu dialyzačnej modality, prijatie cievneho prístupu, skúsenosť s transplantáciou, obavy darcov, postoje k medikácii alebo rozhodovanie o konzervatívnej starostlivosti.

Kvalitatívne dôkazy nie sú náhradou experimentov, kohort ani štatistického modelovania. Odpovedajú na iný typ otázky. Ich hodnota preto nezávisí od toho, či vytvoria percento alebo p-hodnotu, ale od súladu výskumnej otázky, metodológie, výberu účastníkov, zberu dát a transparentnej interpretácie.

Nie je to len „malá štúdia s rozhovormi“

Kvalitatívny výskum je široká skupina metodologických prístupov. Rozhovor alebo fokusová skupina sú metódy zberu dát, nie metodológia sama osebe. Výskumný rámec môže vychádzať napríklad z fenomenológie, zakotvenej teórie, etnografie alebo kvalitatívneho deskriptívneho prístupu. Každý z nich kladie iné otázky a inak pristupuje k analýze.

Medzi bežné zdroje kvalitatívnych dát patria:

- individuálne hĺbkové alebo pološtruktúrované rozhovory,
- fokusové skupiny, ktoré zachytávajú aj interakciu medzi účastníkmi,
- priame alebo zúčastnené pozorovanie klinickej praxe,

- denníky, zdravotné záznamy, dokumenty a písomné naratívy,
- audiozáznamy, videozáznamy alebo digitálny obsah, ak zodpovedajú výskumnej otázke.

Zmiešaný výskum nie je synonymom kvalitatívneho výskumu. Ide o dizajn, ktorý zámerne prepája kvalitatívne a kvantitatívne časti a integruje ich výsledky. Jednoduché pridanie otvorenej otázky na koniec dotazníka ešte nevytvára kvalitný zmiešaný dizajn.

Tri prístupy, tri odlišné druhy odpovedí

Oblasť	Kvantitatívny výskum	Kvalitatívny výskum	Zmiešané metódy
Typická otázka	koľko, ako často, aký je účinok alebo asociácia	ako ľudia jav chápu, prežívajú a vysvetľujú	aký je rozsah javu a ako možno výsledok vysvetliť
Výber účastníkov	často pravdepodobnostný alebo podľa presných kritérií	zvyčajne zámerný výber informačne bohatých prípadov	podľa logiky každej časti a spôsobu ich integrácie
Dáta	merania, kategórie, počty	text, reč, pozorovanie, obraz alebo dokument	číselné aj kvalitatívne dáta
Výstup	odhad účinku, asociácie, prevalencie alebo predikcie	témy, koncepty, mechanizmy, model alebo opis skúsenosti	integrované vysvetlenie alebo návrh intervencie
Prenos výsledkov	štatistická zovšeobecniteľnosť podľa dizajnu a výberu	prenositeľnosť do podobného kontextu po posúdení čitateľom	závisí od oboch častí a kvality integrácie

Ako vzniká dôveryhodná kvalitatívna štúdia

Výber účastníkov býva zámerný: výskumník hľadá ľudí s rozdielnou alebo osobitne informatívnou skúsenosťou. Môže cielene zahrnúť pacientov rôzneho veku, typu liečby, sociálneho zázemia alebo tých, ktorí prijali aj odmietli určitý postup. Cieľom nie je vytvoriť reprezentatívnu miniaturu populácie, ale získať dostatočne bohaté dáta pre zvolenú otázku.

Veľkosť súboru nemožno posúdiť rovnakým výpočtom sily ako v klinickom experimente. Mala by byť zdôvodnená informačnou silou dát, rozsahom otázky, homogenitou účastníkov, kvalitou rozhovorov a analytickým prístupom. Tematická saturácia, teda stav, keď ďalšie dáta neprinášajú významne nové témy, môže byť užitočným konceptom, nie je však univerzálnou ani jedinou podmienkou kvality.

Analýza má byť systematická a dohľadateľná. Výskumníci opisujú, ako vznikali kódy, ako sa z nich vytvorili témy alebo koncepty, ako riešili odlišné interpretácie a či cielene hľadali prípady, ktoré dominantnému vysvetleniu odporovali. Doslovné ukážky výpovedí majú čitateľovi ukázať väzbu medzi dátami a interpretáciou, nie nahradiť samotnú analýzu.

Reflexivita nie je osobný dodatok

Výskumník nie je pri kvalitatívnom výskume neviditeľným meracím prístrojom. Jeho profesia, skúsenosti, predpoklady, vzťah k účastníkom a spôsob kladenia otázok môžu ovplyvniť, čo účastníci povedia aj ako sa dáta vyložia. Reflexivita znamená, že tento vplyv výskumný tím priebežne rozpoznáva, dokumentuje a transparentne opisuje.

Napríklad rozhovor o odmietnutí dialýzy môže vyzerať inak, ak ho vedie ošetrujúci nefrológ, nezávislý výskumník alebo človek so skúsenosťou pacienta. Žiadna z týchto pozícií nie je automaticky nesprávna, ale čitateľ potrebuje vedieť, kto dáta vytvoril a z akej perspektívy ich interpretoval.

Ako štúdiu kriticky čítať

COREQ a SRQR pomáhajú autorom transparentne uviesť podstatné prvky kvalitatívnej práce. Nie sú však bodovacími systémami, ktoré samy potvrdia metodologickú kvalitu. Pri kritickom čítaní sú užitočné najmä tieto otázky:

Oblasť	Čo overiť	Varovný signál

Oblasť	Čo overiť	Varovný signál
Výskumná otázka	je kvalitatívny prístup pre otázku vhodný	témy sa používajú na tvrdenie o účinnosti alebo prevalencii
Metodológia	je rámec pomenovaný a konzistentný s metódami	štúdia uvádza iba „urobili sme rozhovory“
Výber účastníkov	kto bol zahrnutý, kto chýba a prečo	nejasný nábor alebo prehliadnutie dôležitej perspektívy
Kontext	pracovisko, zdravotný systém, kultúrne a sociálne podmienky	čitateľ nevie posúdiť prenositeľnosť
Zber dát	kto rozhovory viedol, kde, ako dlho a podľa akého rámca	vzťah výskumníka k účastníkom nie je uvedený
Analýza	ako vznikli kódy a témy a ako sa riešili rozdielne výklady	témy sa objavia bez vysvetlenia analytického postupu
Reflexivita	ako tím zohľadnil vlastný vplyv a predpoklady	výskumník sa prezentuje ako úplne neutrálny pozorovateľ
Dôkazy a limity	sú interpretácie podložené dátami vrátane odlišných prípadov	selektívne citácie alebo závery presahujúce skúmaný kontext

Príklad: hospic a dialýza v predstavách nefrológov

Spravodajský komentár uviedol kvalitatívnu štúdiu hospicovej starostlivosti pri zlyhaní obličiek. Pôvodná práca bola sekundárnou analýzou pološtruktúrovaných rozhovorov s 20 americkými nefrológmi, ktorí sa vyjadrovali k rozhodovaniu u starších pacientov s pokročilou CKD. Výskumníci opätovne analyzovali časti rozhovorov týkajúce sa hospicu pomocou tematickej analýzy s induktívnym vytváraním tém.

V dátach sa objavili dve prepojené témy: nefrológovia často chápali dialýzu a hospic ako vzájomne sa vylučujúce modely a zároveň si neboli istí, kto má viesť rozhovor o hospici a kto má koordinovať takúto starostlivosť. Výpovede poukázali aj na obavy, že nefrologické ani hospicové tímy nemajú dostatočnú prípravu na spoločnú starostlivosť.

Štúdia však neurčila, aký podiel všetkých nefrológov zastáva tieto názory. Účastníci pochádzali z dvoch terciárnych centier a štyroch komunitných praxí v jednom americkom meste; 85 % z nich bolo v publikácii zaradených do kategórie bielych osôb a 75 % tvorili muži. Išlo iba o perspektívu nefrológov, bez rozhovorov s pacientmi, rodinami a hospicovými pracovníkmi. Navyše americké pravidlá úhrady hospicu a dialýzy nie sú priamo prenosné na Slovensko.

Klinický odkaz je napriek tomu užitočný: paliatívna starostlivosť nie je synonymom hospicu a môže sa poskytovať súbežne s dialýzou. Konzervatívna liečba, rozhodnutie nezačať dialýzu, ukončenie dialýzy a hospicová starostlivosť sú odlišné situácie. Kvalitatívny nález pomohol pomenovať bariéry a navrhnúť otázky pre ďalší výskum; sám osebe nevytvoril všeobecné klinické pravidlo.

Čo môžu kvalitatívne dáta odhaliť v nefrológii

- **Voľba modality:** obavy zo zodpovednosti za domácu liečbu, záťaže blízkych, infekcie, katétra alebo nedostatku priestoru.
- **Cievny prístup:** význam telesného obrazu, strach z bolesti, predchádzajúce skúsenosti a rozdielne chápanie budúcej potreby dialýzy.
- **Medikácia:** liečebná záťaž, nežiaduce účinky, náklady, nedôvera alebo konflikt odporúčania s každodenným režimom.
- **Tekutinový a diétny režim:** smäd, kultúrne zvyklosti, dostupnosť potravín, sociálne situácie a vzťah obmedzení ku kvalite života.
- **Transplantácia:** obavy darcu a príjemcu, rodinné roly, pocit dlhu, stigma a nerovný prístup k informáciám.

- **Konzervatívna starostlivosť:** predstavy o dialýze, prognóze, smrti, záťaži rodiny a prijateľnom výsledku liečby.

Tieto príklady sú možné vysvetlenia, nie predpokladané príčiny správania každého pacienta. Kvalitatívny výskum má zmysel práve preto, že namiesto domýšľania bariér systematicky získava perspektívy ľudí, ktorých sa rozhodnutie týka.

Frekvencia témy nie je jej jedinou hodnotou

Autori niekedy uvedú, koľko účastníkov určitú skúsenosť opísalo. Takýto počet môže orientovať čitateľa v skúmanom súbore, nemožno ho však meniť na populačnú prevalenciu. Zámerný výber a otvorený spôsob zberu dát na takýto odhad spravidla nie sú určené.

Dôležitá téma nemusí byť najčastejšia. Ojedinelý prípad môže odhaliť bezpečnostné riziko, mechanizmus nerovnosti alebo skúsenosť skupiny, ktorá v bežnej praxi zostáva neviditeľná. Kvalitu témy treba posudzovať podľa analytickej hĺbky, súvislosti s dátami a schopnosti vysvetliť skúmaný jav, nie iba podľa počtu citácií.

Kedy sú vhodné zmiešané metódy

Kvalitatívna časť môže najprv identifikovať bariéry a pomôcť vytvoriť dotazník alebo intervenciu, ktorú následne otestuje kvantitatívna štúdia. Opačný postup môže začať nečakaným výsledkom registra alebo klinickej štúdie a rozhovormi potom skúmať, prečo sa intervencia nevyužívala alebo prečo bol účinok medzi pracoviskami rozdielny.

Skutočná sila zmiešaného dizajnu vzniká integráciou. Nestačí publikovať dve paralelné časti. Autori majú ukázať, ako sa výsledky navzájom dopĺňajú, vysvetľujú alebo si odporujú a čo spoločná interpretácia pridáva oproti každému prístupu samostatne.

Od výskumu ku klinickému rozhovoru

Otvorené otázky zlepšujú klinickú komunikáciu, ale bežný rozhovor v ambulancii nie je kvalitatívnou výskumnou štúdiou. Možno však využiť rovnakú zvedavosť a nepredpokladať, že laboratórny výsledok vysvetľuje pacientovo rozhodnutie.

Užitočné otázky môžu znieť:

- „Čo je pre vás pri ochorení obličiek momentálne najťažšie?“
- „Ako rozumiete možnostiam, o ktorých sme hovorili?“
- „Čoho sa pri tejto liečbe najviac obávate?“
- „Ktorá časť plánu je vo vašom každodennom živote ťažko uskutočniteľná?“
- „Čo by pre vás znamenal prijateľný výsledok liečby?“
- „Koho chcete zapojiť do rozhodovania?“

Odpoveď treba overiť, zhrnúť a premietnuť do konkrétneho plánu. Pri komplexnom rozhodnutí môže byť potrebná dialyzačná sestra, nutričný terapeut, sociálny pracovník, psychológ, transplantačný koordinátor alebo paliatívny tím. Multidisciplinarita má riešiť identifikovanú potrebu, nie iba rozšíriť počet ľudí v miestnosti.

Limity hlavného zdroja

Hlavným zdrojom je odborný spravodajský komentár, nie pôvodná štúdia ani systematický prehľad. Upozorňuje na prehliadanú metodologickú oblasť a uvádza ilustratívne príklady, ale nepopisuje systematické vyhľadávanie literatúry ani kritériá výberu citovaných prác.

Preto som metodologické tvrdenia overil v odborných prehľadoch kvalitatívneho výskumu v nefrológii a v odporúčaniach COREQ a SRQR. Príklad hospicovej starostlivosti je interpretovaný podľa pôvodnej štúdie, nie iba podľa spravodajského zhrnutia.

Záver

Kvantitatívne a kvalitatívne dôkazy nesúťažia o miesto v jednej hierarchii. Dobre položená otázka určuje, aký

dizajn je vhodný. Ak potrebujeme odhadnúť účinok, frekvenciu alebo riziko, potrebujeme kvantitatívny prístup. Ak chceme porozumieť skúsenosti, významu, rozhodovaniu a kontextu, kvalitatívny prístup môže priniesť poznanie, ktoré čísla samy nevytvoria.

Pre nefrológiu je tento rozdiel praktický. Liečba môže byť biologicky účinná a technicky dostupná, no pre pacienta neprijateľná alebo neuskutočniteľná. Kvalitatívny výskum pomáha zistiť prečo, bez toho, aby z jednotlivých výpovedí vytváral falošnú prevalenciu alebo univerzálne pravidlo.

Hlavný zdroj: *O'Mary L. The Essential Clinical Research You're Probably Not Reading. Medscape Medical News. 2026. Odkaz na komentár.*

Metodologické zdroje: *Amir N, McCarthy HJ, Tong A. Qualitative Research in Nephrology: An Introduction to Methods and Critical Appraisal. Kidney360. 2021;2(4):737–741. DOI: 10.34067/KID.0006302020. Plný text · Tong A, Sainsbury P, Craig J. COREQ. PubMed · O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. SRQR. PubMed.*

Príklad hospicovej štúdie: *Wachterman MW, Sinha A, Leveille T, Waikar SS, Widera E, Romero K, Bokhour B. Nephrologists' Perspectives and Experiences with Hospice Among Older Adults with End-Stage Kidney Disease. Journal of the American Geriatrics Society. 2024;72(7):2060–2069. DOI: 10.1111/jgs.18936. PubMed.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kvalitativny-vyskum-nefrologia-rozhodovanie-pacientov-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.